

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



«Οι νέοι γιατροί ξεκινούν την καριέρα τους με 20 φάρμακα για μια νόσο, ενώ οι παλιοί γιατροί κλείνουν την καριέρα τους με ένα φάρμακο για 20 νόσους».

William Osler, 1849-1919.

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ

Η οξεία δύσπνοια αποτελεί συχνότατο αίτιο επίσκεψης στο ΤΕΠ και περίπου το 50% των εισαγωγών οξέων περιστατικών στο νοσοκομείο, για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.

Οι ασθενείς, που εμφανίζονται με δύσπνοια, την περιγράφουν με διάφορους τρόπους. Ορισμένοι αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να πάρουν βαθιά ανάσα ή ότι δεν τους φτάνει ο αέρας που αναπνέουν. Άλλοι αναφέρουν ότι αισθάνονται ένα «σφίξιμο στο στήθος» ή ότι χρειάζεται να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναπνεύσουν. Η δύσπνοια μπορεί να ξεκινήσει αιφνίδια, εντός λεπτών ή ωρών και να συνοδεύεται από ξηρό ή παραγωγικό βήχα, σιρίττουσα αναπνοή, πυρετό, θωρακαλγία, αιμόπτυση, αιμωδίες, ζάλη, τρόμο, κ.ά. Μπορεί, επίσης, να έχει μία πιο βαθμιαία εγκατάσταση, σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών.

Η οξεία δύσπνοια διακρίνεται σε **δύσπνοια προσπαθείας** και σε **δύσπνοια ηρεμίας** και συσχετίζεται γενικά με νοσήματα του αναπνευστικού ή/και καρδιακού συστήματος (85%), ενώ η διαφορική διάγνωση αυτών των δύο συστημάτων πρέπει να καλύψει τα πλέον συχνά νοσήματα που παρουσιάζονται στο ιατρείο ή στο ΤΕΠ με εικόνα οξείας δύσπνοιας:

- Παρόξυνση ΧΑΠ (*Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια*), κρίση βρογχικού άσθματος.
- Πνευμονία, υπεζωκοτική συλλογή, αναφυλακτική αντίδραση, λοίμωξη Covid-19.
- Διάμεσες πνευμονοπάθειες (*σαρκοείδωση, πνευμοκονιάσεις, διάμεση πνευμ/κή ίνωση*).
- Πνευμονική εμβολή (*διερεύνηση και αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για ΠΕ*).
- Κακώσεις θώρακα ή διαφράγματος (*πνευμοθώρακας, αυτόματο πνευμομεσοθωράκιο*).
- Βρογχογενής καρκίνος, όγκοι του μεσοθωρακίου ή άλλα ογκολογικά αίτια.
- Καρδιακή ισχαιμία - OEM, καρδιακές αρρυθμίες (*ταχυαρρυθμίες - AF with RVR*).
- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια με οξύ πνευμονικό οίδημα, ARDS.

Υπάρχουν πολλές άλλες αιτίες οξείας δύσπνοιας, όπως επί οξείας νεφρικής βλάβης, σπληναιμίας, σοβαρής αναιμίας, κύησης, παχυσαρκίας, ασκίτη, θυρεοτοξίκωσης, πορφυρίας, διαβητικής κετοξέωσης, μεταβολικής οξέωσης με αναπνευστική αντιρρόπηση, κ.ά.

Η οξεία δύσπνοια μπορεί, επίσης, να είναι ψυχογενούς προέλευσης, όπως επί κρίσεως σωματομετατροπής, αν και αυτή πρέπει να αποτελεί - τελικώς - διάγνωση εξ αποκλεισμού.

Οι ασταθείς ασθενείς, με οξεία δύσπνοια, απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και κατά την κλινική εξέταση μπορεί να εμφανίζονται, χαρακτηριστικά, με τα εξής ευρήματα:

- | | |
|--|--|
| ▪ Υπόταση ($ΣΑΠ < 90 \text{ mmHg}$). | ▪ Μετατόπιση της τραχείας. |
| ▪ Υποξαιμία ($SpO_2 < 90-92\%$). | ▪ Μείωση ή απουσία αναπνευστικών ήχων. |
| ▪ Κυάνωση. | ▪ Μεταβολή επιπέδου συνείδησης, σύγχυση. |
| ▪ Αναπνευστικός συριγμός. | ▪ Καρδιακές αρρυθμίες. |

Σε ασταθείς ασθενείς με οξεία δύσπνοια απαιτείται, άμεσα, η χορήγηση οξυγόνου με προσωπίδα, η εξασφάλιση ενδοφλέβιας γραμμής και φυσικά η έναρξη αρχικής θεραπείας (π.χ. *βρογχοδιασταλικά, διουρητικά*) ανάλογα με την περίπτωση και το πιθανό αίτιο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με οξεία δύσπνοια και συνοδά σημεία και συμπτώματα πιθανής λοίμωξης Covid-19 (ιός SARS-CoV2). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα κατά την εξέταση, όσο και κατά τη θεραπευτική παρέμβαση.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποσυμπίεση με βελόνη, εφόσον η αρχική διαγνωστική εντύπωση αφορά πνευμοθώρακα, καθώς και στη διασωλήνωση αν αυτή κριθεί απαραίτητη.

Οι ασταθείς ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν στο πλησιέστερο ΤΕΠ νοσοκομείου για περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπεία. Εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό (*ειδικά για τα βαρέα περιστατικά*) πρέπει πάντοτε να συνοδεύει τον ασθενή και να συνεχίσει τη διαχείρισή του κατά τη διακομιδή, έως ότου αυτός βρεθεί υπό την επίβλεψη της ομάδας του ΤΕΠ.

Με βάση τις πληροφορίες από το ιστορικό και με τη φυσική εξέταση, ο ιατρός πρέπει να είναι σε θέση να ταξινομήσει την αιτιοπαθογένεια της οξείας δύσπνοιας, είτε ως πιθανά πνευμονικής, ως πιθανά καρδιακής, είτε κάποιας άλλης αιτιολογίας και να κινηθεί ανάλογα.

Στο παρόν κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι σημαντικότερες νοσολογικές οντότητες από το αναπνευστικό σύστημα, που ευθύνονται συχνότερα για επεισόδια οξείας δύσπνοιας.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Καθησυχάζουμε τον ασθενή και προσπαθούμε να πάρουμε γρήγορο και μεστό ιστορικό σχετικά με το επεισόδιο της οξείας δύσπνοιας, είτε από τον ίδιο, είτε από τους οικείους. Αφού προσδιορίσουμε, αδρά, τα πιθανά αίτια της δύσπνοιας, οργανώνουμε τα επόμενα βήματα σχετικά με την προσήκουσα θεραπευτική παρέμβαση, αναλόγως πάντοτε του εκλυτικού αιτίου (παθολογικό, τραυματικό, μεταβολικό, κ.λπ.) και της κλινικής εικόνας.
2. Μετρούμε αρχικώς τα ζωτικά σημεία: [ΑΠ, σφύξεις (HR), αναπνευστική συχνότητα (RR), κορεσμό οξυγόνου (SpO_2)]. Εκτελούμε ΗΚΓ για έλεγχο του ρυθμού και των αρρυθμιών. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς ανά 10-15 λεπτά (ή θέτουμε τον ασθενή σε *monitoring* ζωτικών σημείων και ΗΚΓ), αναλόγως της βαρύτητας της κλινικής εικόνας.
3. Μέχρι να οργανώσουμε το πλάνο αντιμετώπισης κι ώσπου να αρχίσουμε να εξετάζουμε τον ασθενή και να τεθεί η αρχική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται οξυγόνο (O_2) με ροή στα 2-5 lt/min με απλή ρινική κάνουλα ή με ροή στα 6-12 lt/min με τη μάσκα Venturi.
4. Διενεργείται γενική αίματος και αδρός βιοχημικός έλεγχος (Glu, Urea, Creat., AST/ALT, K^+ , Na^+ , Ca^{++} , LDH, CRP, INR, PT, a-PTT, D-Dimers, CPK-MB και Τροπονίνη - cTnI), γενική ούρων, καθώς και έλεγχος αέριων αρτηριακού αίματος (εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο ΚΥ ή στο ΤΕΠ) για ανίχνευση και αξιολόγηση μεταβολικών διαταραχών. Απαραίτητη θεωρείται η ακτινογραφία θώρακος (F/P) και ενίοτε η ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση ή όποια άλλη απεικονιστική εξέταση χρειαστεί, πάντοτε επί ενδείξεων.
5. Τοποθετούμε ευρεία 3way φλεβική γραμμή (16-18G) κι αν είναι εφικτό εξασφαλίζουμε δύο φλεβικές προσπελάσεις, χορηγώντας 500-1000 ml NaCl 0,9% ή R/L ή οποιοδήποτε άλλο κρυσταλλοειδές διάλυμα κριθεί απαραίτητο βάσει των κλινικών ενδείξεων.
6. Εξετάζουμε προσεκτικά τον ασθενή (επισκόπηση, ακρόαση, επίκρουση, ψηλάφηση) και εφόσον υποπτευθούμε Αποφρακτική Πνευμονική Νόσο (ΑΠΝ), δηλαδή άσθμα ή ΧΑΠ, επιχειρούμε άμεσα **βρογχοδιαστολή**, χορηγώντας 1 amp. Berovent (Aerolin + Atrovent) και 1 amp. Budesonide (Pulmicort), σε νεφελοποίηση, με ροή O_2 στα 5-8 lt/min.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η ταχυκαρδία του ασθενούς ($HR > 100-120$ bpm), λόγω της σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας, μας προβληματίζει για τη χορήγηση β_2 -διεγερτών (SABA: Aerolin) για βρογχοδιαστολή. Εντούτοις, όπως έχει καταδειχθεί κλινικά, οι β_2 -διεγέρτες αποτελούν πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία των ΑΠΝ, είτε σε επείγουσα, είτε σε μακροχρόνια βάση.

Στη συνέχεια δρούμε ανάλογα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα αντίστοιχα εδάφια.
7. Στις περιπτώσεις που το επεισόδιο αιφνίδιας δύσπνοιας οφείλεται σε **καρδιολογικό αίτιο** (π.χ. βαριά υπόταση, καρδιακή ανεπάρκεια - ΟΠΟ, OEM, βραδυ- ή ταχυαρρυθμίες, κ.ά.) δρούμε αναλόγως, στοχεύοντας πάντοτε στην άμεση αντιμετώπιση του γενεσιουργού καρδιολογικού αιτίου (π.χ. ενυδάτωση, αντιυπερτασικά, διουρητικά, αντιαιμοπεταλιακά, αντιαρρυθμικά, οξυγονοθεραπεία, κ.λπ.), όπως αναγράφεται στα αντίστοιχα εδάφια.
8. Εάν το επεισόδιο οξείας δύσπνοιας πυροδοτήθηκε από κάποιο άλλο **παθολογικό αίτιο** (π.χ. λοιμώδης ή σηπτική κατάσταση, γνωστή πνευμονική κακοήθεια, μεταβολική οξέωση, βαριά αναιμία, δηλητηρίαση, κ.λπ.), τότε – εκτός της δύσπνοιας – μεριμνούμε για την παράλληλη αρχική αντιμετώπιση του εκλυτικού αιτίου που πυροδότησε τη δύσπνοια, δρώντας ανάλογα (π.χ. ενυδάτωση, οξυγόνωση, αναλγησία, χορήγηση αντιδότηων, κ.λπ.).
9. Εάν το εκλυτικό αίτιο της δύσπνοιας είναι **τραυματικό** (π.χ. έγκλημα - εισπνοή καπνού, κάκωση θώρακα, κάκωση ΘΜΣΣ, πνευμοθώρακας, κ.λπ.), αφού αρχικώς διορθώσουμε την πιθανή υποξεία λόγω της αναπνευστικής δυσχέρειας, εν συνεχεία αντιμετωπίζουμε την απειλητική για τη ζωή αιτία, με βάση τους διεθνείς αλγόριθμους (ALS και ATLS).
10. Εφόσον η κατάσταση του ασθενούς παραμένει στάσιμη ή επιδεινώνεται ή/και εφόσον ο εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος αναδεικνύει σοβαρή και απειλητική νόσο, τότε διακομίζουμε τάχιστα τον ασθενή στο νοσοκομείο, υπό συνεχές *monitoring* (ΗΚΓ, HR, ΑΠ, RR, SpO_2), πάντα συνοδεία ιατρού, συνεχίζοντας κι εντός του ασθενοφόρου τη δέουσα θεραπευτική αγωγή, αναλόγως πάντα του εκλυτικού αιτίου ή της κύριας νόσου.